



การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended-Essay)
เรื่อง การพัฒนาเกมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตผ่านมุมมองผู้อื่น



จัดทำโดย

นายกฤษฎ์ดิคุณ วงษ์นิล	เลขที่ 16
นายเทพศิรินทร์ ลีกุล	เลขที่ 25
นายณัฐชนน ประดับ	เลขที่ 26
นายบวรวิทย์ ปัญญาธนะโสภณ	เลขที่ 31
นายหรรษกานต์ เกษมพิณ	เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นำเสนอ

มิสพรทิพย์ สังเกต

มิสสุภาณี สุภาพ

มิสพัฒน์ สกุลช่างเสนาะ

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสังคมที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียน ความสำเร็จ และภาพลักษณ์ภายนอก ทำให้นักเรียนหลายคนต้องแบกรับความกดดันทั้งจากตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง โดยที่ความรู้สึกและความยากลำบากทางอารมณ์เหล่านี้มักไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างชัดเจน

บุคคลจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางอารมณ์หรือความเครียดสะสม มักเลือกที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง และแสดงออกต่อผู้อื่นด้วยท่าทีปกติ ร่าเริง หรือมั่นคง ทั้งที่ภายในกำลังเผชิญกับความยากลำบาก การที่พฤติกรรมภายนอกไม่สอดคล้องกับสภาวะภายในนี้ ทำให้คนรอบข้าง เพื่อน หรือแม้แต่ครอบครัว ไม่สามารถสังเกตเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญอยู่ได้

สื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะวิดีโอเกม มีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือสื่อสารประเด็นทางสังคมและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกมเป็นสื่อเชิงโต้ตอบ (Interactive Media) ที่ผู้เล่นไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารแบบเฉื่อย แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงผ่านการตัดสินใจและการเลือก อย่างไรก็ตาม เกมที่นำเสนอประเด็นสุขภาพจิตในลักษณะที่ละเอียดอ่อน สมจริง และไม่ตีตราผู้ที่มีความยากลำบากทางอารมณ์ ยังมีอยู่อย่างจำกัด

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเกมวิชวลโนเวล (Visual Novel) ที่ชื่อว่า *Untitled Illness* ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาผ่านมุมมองของตัวละครหลายตัว โดยให้ผู้เล่นได้สัมผัสเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวละครแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น โดยไม่มุ่งเน้นการวินิจฉัยหรือให้คำจำกัดความปัญหาสุขภาพจิตแต่อย่างใด แต่เน้นการสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมที่ปรากฏภายนอกอาจไม่ได้สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงภายในของบุคคลนั้นเสมอไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเกมวิชวลโนเวลที่นำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าความยากลำบากทางอารมณ์อาจไม่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเสมอไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นเกมเกิดการไตร่ตรองเกี่ยวกับการสื่อสาร การให้กำลังใจ และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน
4. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้วิดีโอเกมเป็นสื่อกลางเชิงโต้ตอบในการนำเสนอประเด็นทางสังคมและอารมณ์

ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

1. ได้เกมวิชวลโนเวลต้นแบบที่สามารถใช้เป็นสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ในกลุ่มนักเรียน
2. ผู้เล่นเกมมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น ผ่านการรับรู้มุมมองที่หลากหลายของตัวละครในเกม
3. เป็นแนวทางและกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบที่นำเสนอประเด็นทางสังคมและจิตใจในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
4. ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะด้านการออกแบบเกม การเขียนบทเรื่องราว การเขียนโปรแกรม และการออกแบบระบบเชิงอารมณ์ภายในเกม

นิยามศัพท์

วิชวลโนเวล (Visual Novel) คือ ประเภทของเกมที่เล่าเรื่องผ่านบทสนทนา ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบฉาก และตัวเลือกที่ผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ระหว่างการดำเนินเรื่อง

มุมมองตัวละคร (Character Perspective / Route) คือ เส้นทางการเล่นเรื่องที่นำเสนอผ่านสายตาและความคิดของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งทำให้ผู้เล่นได้รับรู้เหตุการณ์เดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป

การรับรู้มุมมองผู้อื่น (Perspective-taking) คือ กระบวนการที่ผู้เล่นสวมบทบาทหรือมองเหตุการณ์ผ่านสายตาของตัวละครอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของบุคคลนั้น

สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Wellbeing) คือ สภาวะความสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคล ซึ่งในบริบทของเกมนี้หมายถึงประเด็นที่เกมต้องการสื่อสารในเชิงสร้างความตระหนักรู้ มีใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์

ขอบเขตการทำโครงการ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบและพัฒนาเกมวีซวลโนเวล *Untitled Illness* ซึ่งนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน โดยศึกษาผลกระทบของการเล่าเรื่องแบบหลายมุมมองและระบบน้ำหนัทางอารมณ์ที่มีต่อความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการรับรู้ของผู้เล่นต่อประเด็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ในวัยเรียน เกมมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหรือให้การรักษาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตแต่อย่างใด

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง

การเก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็นจากผู้เล่น โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกมในรูปแบบไฟล์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Godot 4 และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์หลังการเล่น

การศึกษานี้มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลของการออกแบบเกมเชิงเล่าเรื่องที่มีต่อความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผู้เล่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาวะทางอารมณ์ในกลุ่มนักเรียนต่อไป

ตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ตัวแปรต้น : มุมมองตัวละครที่ผู้เล่นเลือกดำเนินเรื่องผ่าน ตัวเลือกบทสนทนาที่ผู้เล่นเลือกระหว่างการเล่น

ตัวแปรตาม : ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผู้เล่นที่มีต่อตัวละคร

ตัวแปรควบคุม : โครงสร้างพื้นฐานของเกม สภาพแวดล้อมและบริบทของเรื่องราว กลุ่มผู้เล่นที่ใช้ในการทดสอบเกมมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของเกม

วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตในวัยรุ่น รูปแบบเกมวีชวลโนเวล และกลไกการเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเนื้อหาและระบบเกม
2. กำหนดโครงเรื่องหลัก พัฒนาตัวละคร และเส้นทางมุมมองของแต่ละตัวละคร พร้อมทั้งเขียนบทสนทนาและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
3. พัฒนาโปรแกรมเกม ดำเนินการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Godot 4 โดยเขียนสคริปต์ด้วยภาษา GDScript สำหรับระบบบทสนทนา ระบบฉากแขนงของเนื้อเรื่อง และระบบบันทึก/ย้อนกลับสถานะ
4. จัดทำฉากพื้นหลัง สไลด์ตัวละคร และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ รวมถึงออกแบบเสียงประกอบที่ปรับเปลี่ยนไปตามระดับความกดดันทางอารมณ์ของตัวละคร
5. นำเกมไปทดลองเล่นเพื่อตรวจสอบความสับสนไหลของเนื้อเรื่อง ความถูกต้องของระบบตัวเลือก และประสิทธิภาพของการสื่อสารประเด็นทางอารมณ์
6. นำผลจากการทดสอบมาปรับปรุงเนื้อหา ระบบเกม และการนำเสนอให้มีความสมบูรณ์
7. รวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมด จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอ/เผยแพร่ผลงาน

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเกมวีลโนเวล *Untitled Illness* ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบเนื้อหา ระบบเกม และวิธีการนำเสนอประเด็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. แนวคิดและคุณสมบัติของเกมเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้าน

สุขภาพจิต

1.1 ความหมายและลักษณะของเกมเพื่อการเรียนรู้และการตระหนักรู้

1.2 เกมแนว Visual Novel

1.3 การเล่าเรื่องผ่านเกมและมุมมองของตัวละคร

1.4 การใช้เกมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยรุ่น

2.1 ความหมายของสุขภาพจิต

2.2 สุขภาพจิตและความเครียดในวัยรุ่น

2.3 การเก็บกดและการไม่แสดงออกทางอารมณ์

2.4 ความสำคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนทางอารมณ์

3. แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเกม *Untitled Illness*

3.1 การออกแบบตัวละครและบุคลิกภาพ

3.2 การออกแบบเนื้อเรื่องและเส้นทางของตัวละคร

3.3 ระบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น

3.4 ระบบ Emotional Weight และการแสดงสภาวะทางอารมณ์

3.5 การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อสื่อสารอารมณ์

3.6 การใช้ภาพ เสียง และบรรยากาศในการสร้างอารมณ์

4. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านสื่อ Interactive

4.1 ความหมายของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

4.2 การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านมุมมองของตัวละคร

4.3 ผลของการมีส่วนร่วมของผู้เล่นต่อประสบการณ์ทางอารมณ์

4.4 การใช้ Interactive Media เพื่อสร้างประสบการณ์และการสะท้อนความคิด

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม

5.1 โปรแกรม Godot Engine และ ภาษา GDScript

6. งานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเกมกับการส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างความเห็นอกเห็นใจ
- 6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับ Interactive Storytelling และประสบการณ์ของผู้เล่น
- 6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับ Visual Novel และการเล่าเรื่อง
- 6.4 การวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับ Untitled Illness

1. แนวคิดและคุณสมบัติของเกมเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต

1.1 ความหมายและลักษณะของเกมเพื่อการเรียนรู้และการตระหนักรู้

เกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายอื่นนอกเหนือไปจากความบันเทิงเพียงอย่างเดียว มักถูกเรียกรวมกันว่า "เกมจริงจัง" หรือ Serious Games ซึ่ง Michael และ Chen (2006) อธิบายว่าเป็นเกมที่ยังคงใช้กลไกและองค์ประกอบของเกมตามปกติ เช่น กฎ เงื่อนไข และการโต้ตอบ แต่นำกลไกเหล่านั้นไปปรับใช้วัตถุประสงค์เชิงการศึกษา การฝึกอบรม หรือการสื่อสารข้อมูลบางอย่างแก่ผู้เล่น จุดเด่นของเกมประเภทนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ความยากหรือความท้าทาย แต่อยู่ที่ความสามารถในการทำให้ผู้เล่นได้ "ลงมือทำ" กับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร แทนที่จะรับข้อมูลในลักษณะการอ่านหรือการฟังเพียงอย่างเดียว

เมื่อพิจารณาเฉพาะในบริบทของสุขภาพจิต เกมกลุ่มนี้สามารถแบ่งบทบาทออกได้อย่างน้อยสองลักษณะ ลักษณะแรกคือเกมที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยบำบัดโดยตรง ซึ่งมักพัฒนาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และมีการทดสอบประสิทธิผลเชิงคลินิก ลักษณะที่สองคือเกมที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ โดยไม่ได้ทำหน้าที่วินิจฉัยหรือรักษา แต่ช่วยลดความเข้าใจผิดและอคติที่สังคมมีต่อผู้ที่กำลังเผชิญความยากลำบากทางอารมณ์ (Ferrari et al., 2019) เกม Untitled Illness จัดอยู่ในลักษณะที่สอง กล่าวคือเป็นสื่อเพื่อการตระหนักรู้และการสะท้อนความคิด มิใช่เครื่องมือทางการแพทย์

1.2 เกมแนว Visual Novel

วิชวลโนเวลเป็นประเภทของเกมที่ทำให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องเป็นหลัก Cavallaro (2010) ระบุว่าวิชวลโนเวลดำเนินเรื่องผ่านบทสนทนาจำนวนมาก ประกอบกับภาพพื้นหลังที่ส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง กล่องข้อความ และสไปรต์ตัวละคร โดยผู้เล่นมีส่วนกำหนดจุดเปลี่ยนของเรื่องผ่านการเลือกในช่วงเวลาสำคัญ ส่งผลให้ตอนจบเปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจ และเป็นเหตุผลให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำเพื่อทดลองเส้นทางอื่น

อย่างไรก็ตาม คำนิยามของวิชวลโนเวลในแวดวงวิชาการมีความหลากหลายมาก Camingue, Carstensdóttir และ Melcer (2021) ได้วิเคราะห์คำนิยามทางวิชาการ 30 คำนิยาม ร่วมกับการวิเคราะห์เกมวิชวลโนเวลจริงจำนวน 54 เกม และพบว่าคำนิยามที่มีอยู่เดิมมักครอบคลุมองค์ประกอบของแนวเกมเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงได้เสนอคำนิยามที่รวมองค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน ได้แก่ การเล่าเรื่องที่อาศัยข้อความเป็นหลัก การใช้ภาพนิ่งประกอบ โครงเรื่องแบบแตกแขนง และตัวเลือกที่ส่งผลต่อทิศทางและตอนจบของเรื่อง

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้วีลโนเวลเหมาะสมกับโครงการที่ต้องการสื่อสารประเด็นทางอารมณ์ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เปิดพื้นที่ให้กับความคิดภายในของตัวละครได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าเกมแนวอื่น และเอื้อต่อการสร้างเส้นทางเรื่องหลายเส้นภายในโครงงานขนาดเล็ก

1.3 การเล่าเรื่องผ่านเกมและมุมมองของตัวละคร

Murray (1997) เสนอว่าสื่อดิจิทัลมีคุณสมบัติที่สื่อดั้งเดิมไม่มี โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านการมีส่วนร่วม (agency) ซึ่งหมายถึงความรู้สึกของผู้ใช้ว่าการกระทำของตนส่งผลกระทบต่อโลกของเรื่องเล่าอย่างมีความหมาย ในบริบทของเกม คุณสมบัตินี้เปลี่ยนสถานะของผู้รับสารจาก "ผู้ชมเหตุการณ์" เป็น "ผู้ร่วมก่อให้เกิดเหตุการณ์"

ความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อประเด็นทางอารมณ์ เพราะเมื่อผู้เล่นเป็นผู้เลือกคำพูดหรือการกระทำของตัวละครด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงถูกรับรู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นในระดับหนึ่ง มิใช่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น Carstensdóttir และคณะได้ชี้ให้เห็นในงานศึกษาปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นในเกมเชิงเล่าเรื่องว่า รูปแบบการให้ตัวเลือกและวิธีที่เกมตอบสนองต่อตัวเลือกนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าผู้เล่นจะรู้สึกว่ามีบทบาทต่อเรื่องมากน้อยเพียงใด (Camingue et al., 2021)

การเล่าเรื่องแบบหลายมุมมองคือการนำเสนอเหตุการณ์ชุดเดียวกันผ่านสายตาของตัวละครหลายตัว ทำให้ผู้รับสารได้ข้อมูลที่ตัวละครแต่ละตัวไม่มีทางรู้เกี่ยวกับกันและกัน โครงสร้างลักษณะนี้สร้าง "ช่องว่างของข้อมูล" ระหว่างสิ่งที่ผู้เล่นรู้กับสิ่งที่ตัวละครในเรื่องรู้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ผู้เล่นเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ดูเรียบง่ายหรือดูเป็นขาของใครคนหนึ่ง อาจมีที่มาที่คนรอบข้างมองไม่เห็น

แนวคิดนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ Belman และ Flanagan (2010) ที่ว่าเกมมีความเหมาะสมเป็นพิเศษต่อการส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าไปอยู่ในบทบาทและมุมมองของผู้อื่นในลักษณะที่สื่อประเภทอื่นทำได้ยาก

1.4 การใช้เกมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

Belman และ Flanagan (2010) ได้สังเคราะห์หลักการออกแบบสำหรับเกมที่ต้องการกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจ โดยเน้นว่าการให้ผู้เล่นสวมบทบาทเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้เล่นจำเป็นต้องมีเจตนาที่จะทำความเข้าใจตัวละครตั้งแต่ต้น และเกมควรออกแบบให้การพยายามเข้าใจนั้นมีความหมายต่อการเล่น นอกจากนี้ยังควรระวังไม่ให้เกมนำเสนอปัญหาในลักษณะที่ง่ายเกินจริงหรือชี้นำคำตอบมากเกินไป เพราะอาจทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าคุณเข้าใจสถานการณ์อย่างครบถ้วนแล้วทั้งที่ยังไม่ใช่

ในเชิงประจักษ์ Ferchaud, Seibert, Sellers และ Escobar Salazar (2020) ได้ทดลองกับเกม *Hellblade: Senua's Sacrifice* โดยเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้เล่นเกมด้วยตนเองกับกลุ่มที่เพียงรับชมการเล่น ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้เล่นเองรายงานระดับการถูกดึงเข้าสู่โลกของเรื่อง (transportation) สูงกว่า และการถูกดึงเข้าสู่เรื่องนี้นำไปสู่การรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร ซึ่งท้ายที่สุดสัมพันธ์กับความต้องการรักษาระยะห่างทางสังคมจากผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ลดลง ผลดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานว่า "การได้เล่น" ให้ผลต่างจาก "การได้ดู" อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่โครงการนี้เลือกใช้เกมเป็นสื่อ

2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยรุ่น

2.1 ความหมายของสุขภาพจิต

องค์การอนามัยโลกนิยามสุขภาพจิตว่าเป็นภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ ซึ่งบุคคลสามารถรับมือกับความเครียดตามปกติของชีวิต ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมชุมชนของตนได้ (World Health Organization, 2024) นิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าสุขภาพจิตไม่ใช่เพียงการ "ไม่มีโรค" แต่เป็นเรื่องของความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นกรอบที่เกม *Untitled Illness* ใช้ในการนำเสนอเรื่องราว กล่าวคือ เกมมิได้นำเสนอตัวละครในฐานะ "ผู้ป่วย" แต่นำเสนอในฐานะนักเรียนที่กำลังจัดการกับความกดดันในชีวิตประจำวันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

2.2 สุขภาพจิตและความเครียดในวัยรุ่น

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าวัยรุ่นอายุ 10–19 ปีทั่วโลกประมาณ 1 ใน 7 คน กำลังเผชิญภาวะทางสุขภาพจิตบางประการ คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 14 ของประชากรวัยนี้ โดยภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยที่สุด และปัญหาส่วนใหญ่ยังคงไม่ถูกรับรู้และไม่ได้รับการดูแล (World Health Organization, 2024)

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านระบบ Mental Health Check In ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงในรายงานภาวะสังคมไทย ระบุว่าในปี 2566 เยาวชนที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 18.0 มีความเครียดสูง ร้อยละ 26.0 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า และร้อยละ 12.5 เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2567) ขณะที่ข้อมูลสะสมระหว่างปี 2563–2567 พบว่าเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเครียดสูงร้อยละ 24.83 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 29.51 และเสี่ยงฆ่าตัวตายเป็นร้อยละ 20.35 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรไทยทุกช่วงวัยอย่างชัดเจน (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2567)

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าความยากลำบากทางอารมณ์ในวัยรุ่นไม่ใช่กรณียกเว้น แต่เป็นประสบการณ์ที่พบได้ทั่วไปในระดับที่ควรได้รับความสนใจ และเป็นเหตุผลรองรับความจำเป็นของสื่อที่ช่วยสร้างความเข้าใจในกลุ่มนักเรียนด้วยตนเอง

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นมีลักษณะสะสม กล่าวคือ ยิ่งวัยรุ่นเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างพร้อมกัน ผลกระทบต่อสุขภาพจิตก็ยิ่งมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงความกดดันจากเพื่อน การถูกกลั่นแกล้ง ความขัดแย้งในครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่ขาดการสนับสนุน ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ทำหน้าที่เป็นปัจจัยปกป้องที่สำคัญ (World Health Organization, 2024)

ในบริบทของสังคมไทย ความคาดหวังด้านผลการเรียนและการสอบเข้าศึกษาต่อเป็นแหล่งความกดดันที่โดดเด่น รายงานของกรมสุขภาพจิตระบุว่าปัจจัยกระตุ้นที่พบบ่อยในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อน และการถูกตำหนิ (กรมสุขภาพจิต, 2565) การออกแบบฉากในเกม Untitled Illness จึงเลือกใช้สถานที่ธรรมดาอย่างห้องเรียน โรงอาหาร และห้องนอน เพราะเป็นพื้นที่ที่ปัจจัยกดดันเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

2.3 การเก็บกดและการไม่แสดงออกทางอารมณ์

หัวใจของเนื้อเรื่องใน Untitled Illness คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตัวละครแสดงออกกับสิ่งที่ตัวละครรู้สึกจริง ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องกลยุทธการกำกับอารมณ์ของ Gross และ John (2003) ที่จำแนกกลยุทธหลักไว้สองแบบ ได้แก่ **การประเมินสถานการณ์ใหม่ (cognitive reappraisal)** ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีตีความสถานการณ์ก่อนที่อารมณ์จะก่อตัวเต็มที่ และ **การเก็บกดการแสดงออก (expressive suppression)** ซึ่งเป็นการยับยั้งพฤติกรรมที่บ่งบอกอารมณ์ขณะที่อารมณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นแล้ว

ผลการศึกษาของ Gross และ John (2003) พบว่าผู้ที่ใช้การเก็บกดเป็นประจำมีแนวโน้มแสดงออกและรับรู้อารมณ์ทางบวกได้น้อยลง ขณะเดียวกันกลับประสบอารมณ์ทางลบมากขึ้น อีกทั้งยังสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ทางสังคมที่แย่ลงและความเป็นอยู่ที่ดีในระดับต่ำกว่า ในทางกลับกัน ผู้ที่ใช้การประเมินสถานการณ์ใหม่มีแนวโน้มมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

ข้อค้นพบนี้ถูกนำมาใช้เป็นฐานของระบบ Emotional Weight โดยตรง กล่าวคือ ตัวเลือกที่เป็นการเก็บกดหรือปฏิเสธความรู้สึกจะเพิ่มน้ำหนักทางอารมณ์ของตัวละครสะสมขึ้นเรื่อย ๆ แม้ในระยะสั้นตัวละครจะดู "ปกติ" ในสายตาของตัวละครอื่นก็ตาม

2.4 ความสำคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนทางอารมณ์

แม้วัยรุ่นจะเผชิญปัญหาทางอารมณ์ในสัดส่วนสูง แต่กลับมีแนวโน้มไม่ขอความช่วยเหลือ Gulliver, Griffiths และ Christensen (2010) ได้ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับอุปสรรคและปัจจัยเอื้อต่อการขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของคนหนุ่มสาว และพบว่าอุปสรรคที่ถูกรายงานมากที่สุดคือ การตีตราและความอับอาย ตามมาด้วยปัญหาในการรับรู้และสื่อสารอาการของตนเอง รวมถึงความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่าจะพึ่งพาผู้อื่น ส่วนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการขอความช่วยเหลือ ได้แก่ ประสิทธิภาพเชิงบวกในอดีตและการได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิด

ข้อค้นพบนี้อธิบายพฤติกรรมของตัวละคร Kay ได้โดยตรง คือความกลัวว่าการเปิดเผยปัญหาของตนจะกลายเป็นภาระของผู้อื่น และยังชี้ให้เห็นว่าบทบาทของ "เพื่อน" ในการรับฟัง เป็นกลไกทางสังคมที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าบริการทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นประเด็นที่โครงการนี้ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

3. แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเกม Untitled Illness

3.1 การออกแบบตัวละครและบุคลิกภาพ

ตัวละครในเกมถูกออกแบบให้สะท้อนรูปแบบการรับมือกับความกดดันที่แตกต่างกัน แทนที่จะแทนค่าด้วยอาการทางคลินิกใดอาการหนึ่ง แนวทางนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ Ferrari และคณะ (2019) ที่วิเคราะห์การนำเสนอภาวะทางจิตในวิดีโอเกมและพบว่า เกมจำนวนมากยังคงผลิตซ้ำภาพเหมารวมเชิงลบ การออกแบบที่หลีกเลี่ยงการตีตราจึงควรนำเสนอตัวละครในฐานะบุคคลที่มีชีวิตรอบด้าน มิใช่ในฐานะตัวแทนของอาการ

ตัวละครหลักอย่าง Kay ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะภายนอกที่มั่นคงและน่าพึ่งพา จนกลายเป็นที่ปรึกษาของเพื่อน ขณะที่ภายในกลับใช้เวลาไปกับการคิดวนและความกังวลที่ไม่เคยถูกพูดออกมา โครงสร้างตัวละครลักษณะนี้เป็นภาพแทนของการเก็บกดการแสดงออกตามกรอบของ Gross และ John (2003) ส่วนตัวละครอื่นสะท้อนรูปแบบการรับมือที่ต่างออกไป เช่น การทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา ความรู้สึกผิดที่ค้างคา หรือการแยกตัวจากผู้อื่น

3.2 การออกแบบเนื้อเรื่องและเส้นทางของตัวละคร

เกมใช้โครงสร้างแบบหลายเส้นทาง (route) โดยแต่ละเส้นทางนำเสนอเหตุการณ์ในโรงเรียนผ่านมุมมองของตัวละครต่างคนกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของวิซวลโนเวลตามค่านิยมของ Camingue และคณะ (2021) ที่ให้ความสำคัญกับโครงเรื่องแบบแตกแขนงและตอนจบที่หลากหลาย

จุดประสงค์ของการใช้หลายเส้นทางในโครงการนี้มีไว้เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหา แต่เพื่อสร้างการทับซ้อนของเหตุการณ์ กล่าวคือ เหตุการณ์เดียวกันจะปรากฏซ้ำในเส้นทางที่ต่างกัน โดยผู้

เล่นจะได้รับข้อมูลภายในของตัวละครคนละชุด ทำให้การตีความเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปเมื่อเล่นซ้ำ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสื่อสารสาระสำคัญของเกม

3.3 ระบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น

ตัวเลือกในเกมถูกออกแบบให้เป็นตัวเลือกเชิงการสื่อสาร เช่น จะพูดความจริง จะเปลี่ยนเรื่อง หรือจะบอกว่าตนเอง "ไม่เป็นไร" มากกว่าจะเป็นตัวเลือกเชิงถูกผิดที่มีคำตอบตายตัว การออกแบบเช่นนี้อาศัยแนวคิดเรื่องความรู้สึกร่วมกันของ Murray (1997) กล่าวคือ ตัวเลือกมีความหมายต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ตนเลือกกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา

ในขณะเดียวกัน Belman และ Flanagan (2010) เตือนว่าเกมเพื่อความเห็นอกเห็นใจไม่ควรทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนดูเหมือนมีทางออกที่ง่ายเกินจริง ตัวเลือกใน *Untitled Illness* จึงไม่ถูกออกแบบให้มีตัวเลือกที่ "แก้ปัญหาได้" ในทันที แต่ให้ผลในลักษณะของการบรรเทาชั่วคราวหรือการสะสมความกดดันเพิ่มขึ้นเท่านั้น

3.4 ระบบ Emotional Weight และการแสดงสภาวะทางอารมณ์

ระบบ Emotional Weight คือค่าสถานะภายในที่แทนปริมาณความกดดันทางอารมณ์ที่ตัวละครกำลังแบกรับ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Low, Medium, High และ Critical โดยระดับที่สูงขึ้นจะส่งผลให้จำนวนตัวเลือกที่ใช้ได้ลดลง ข้อความปรากฏช้าลง และบรรยากาศโดยรวมเจ็บลง

จุดสำคัญคือระบบนี้มีได้ทำหน้าที่วัดสุขภาพจิตของบุคคลจริง แต่เป็นกลไกเชิงการเล่าเรื่องที่แปลงข้อค้นพบทางจิตวิทยาให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้เล่นสัมผัสได้ กล่าวคือ เมื่อผู้เล่นพบว่าตนเองมีตัวเลือกให้เลือกน้อยลงเรื่อย ๆ ผู้เล่นจะรับรู้ข้อจำกัดนั้นด้วยตนเอง แทนที่จะถูกบอกผ่านข้อความบรรยาย แนวทางนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ferchaud และคณะ (2020) ที่ชี้ว่าการที่ผู้เล่นได้ลงมือเล่นเองส่งผลต่อการเข้าไปอยู่ในโลกของเรื่องมากกว่าการเฝ้าดู

การออกแบบให้ระดับความกดดันเพิ่มขึ้นจากการเลือกเก็บกดซ้ำ ๆ และลดลงจากปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุน สะท้อนข้อค้นพบของ Gross และ John (2003) เกี่ยวกับผลสะสมของการเก็บกดการแสดงออก และข้อค้นพบของ Gulliver และคณะ (2010) เกี่ยวกับบทบาทของการสนับสนุนจากคนรอบข้าง

3.5 การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อสื่อสารอารมณ์

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ในเกมทำหน้าที่มากกว่าการแสดงข้อความ โดยถูกใช้เป็นช่องทางสื่อสารสภาวะภายในของตัวละคร เช่น ความเร็วในการแสดงข้อความ จำนวนตัวเลือกที่ปรากฏ และ

ความอึดตัวของสีในหน้าจอ แนวคิดการใช้ส่วนต่อประสานเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องนี้ ตรงกับข้อสังเกตของ Camingue และคณะ (2021) ที่ว่าองค์ประกอบด้านการโต้ตอบเป็นคุณลักษณะที่แยกไม่ออกจากการนิยามวิซวลโนเวล มิใช่เพียงเปลี่ยนนอกที่ห่อหุ้มเนื้อเรื่อง

3.6 การใช้ภาพ เสียง และบรรยากาศในการสร้างอารมณ์

เกมเลือกใช้ฉากที่คุ้นเคยในชีวิตนักเรียน และปรับเปลี่ยนการนำเสนอไปตามระดับความกดดันของตัวละคร ในด้านเสียง เมื่อตัวละครอยู่ในสภาวะที่มั่นคง เสียงสภาพแวดล้อมจะชัดเจน แต่เมื่อความกดดันเพิ่มขึ้น เสียงรอบข้างจะค่อย ๆ เบาลงจนเหลือเพียงเสียงภายใน เพื่อสร้างความรู้สึกแยกตัวและการหันเข้าหาความคิดของตนเอง เทคนิคดังกล่าวทำงานร่วมกับแนวคิดเรื่องการถูกดึงเข้าสู่โลกของเรื่อง (transportation) ซึ่ง Ferchaud และคณะ (2020) ระบุว่าเป็นตัวแปรส่งผ่านสำคัญที่นำไปสู่การรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร

4. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านสื่อ Interactive

4.1 ความหมายของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

Davis (1983) เสนอว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่คุณลักษณะเดียว แต่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่แยกจากกันได้ ได้แก่ การรับรู้มุมมองของผู้อื่น (perspective taking) ความห่วงใยเห็นใจ (empathic concern) การเข้าไปอยู่ในโลกของเรื่องแต่ง (fantasy) และความทุกข์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นลำบาก (personal distress)

การจำแนกนี้มีประโยชน์ต่อโครงการ เพราะชี้ว่าเป้าหมายของเกมควรอยู่ที่การส่งเสริมการรับรู้มุมมองของผู้อื่นและความห่วงใย มากกว่าการทำให้ผู้เล่นรู้สึกทุกข์ตามตัวละคร ซึ่งอาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงสถานการณ์แทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

4.2 การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านมุมมองของตัวละคร

Belman และ Flanagan (2010) แยกความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าใจสถานะจิตใจของผู้อื่น ออกจากความเห็นอกเห็นใจเชิงอารมณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมรู้สึก พร้อมทั้งชี้ว่าการเข้าใจโดยปราศจากการร่วมรู้สึกไม่ได้นำไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกเสมอไป เกมที่ออกแบบมาเพื่อความเห็นอกเห็นใจจึงควรกระตุ้นทั้งสองด้านควบคู่กัน

Untitled Illness ตอบโจทย์ด้านปัญญาด้วยการเปิดเผยความคิดภายในของตัวละครที่ตัวละครอื่นไม่รับรู้ และตอบโจทย์ด้านอารมณ์ด้วยการให้ผู้เล่นเป็นผู้ตัดสินใจแทนตัวละครในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกที่ได้อย่างแท้จริง

4.3 ผลของการมีส่วนร่วมของผู้เล่นต่อประสบการณ์ทางอารมณ์

Green และ Brock (2000) เสนอแนวคิดเรื่องการถูกดึงเข้าสู่เรื่องเล่า (narrative transportation) ว่าเป็นภาวะที่ผู้รับสารจดจ่อกับโลกของเรื่องจนความสนใจต่อโลกภายนอกลดลง และพบว่าภาวะนี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้สอดคล้องกับเรื่องที่ได้รับ

งานของ Ferchaud และคณะ (2020) ได้ขยายแนวคิดนี้มาสู่บริบทของเกม โดยแสดงให้เห็นเส้นทางความสัมพันธ์จากการได้เล่นเกม ไปสู่การถูกดึงเข้าสู่เรื่อง ไปสู่การรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร และนำไปสู่การลดลงของความต้องการรักษาระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อภาพเหมารวม (stereotyping) ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ควรพิจารณาในการตั้งความคาดหวังของโครงการนี้ กล่าวคือ เกมอาจช่วยลดระยะห่างและเพิ่มความเต็มใจที่จะเข้าใกล้ผู้อื่นได้ แต่การเปลี่ยนความเชื่อที่ฝังลึกเป็นเรื่องที่ต้องใช้มากกว่าการเล่นเกมเพียงครั้งเดียว

4.4 การใช้ Interactive Media เพื่อสร้างประสบการณ์และการสะท้อนความคิด

คุณค่าเฉพาะของสื่อเชิงโต้ตอบอยู่ที่ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ผู้เล่นต้อง "รับผิดชอบ" ต่อผลของการเลือกของตน Murray (1997) อธิบายว่าสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ใช้ได้ทดลองความเป็นไปได้หลายแบบภายในโลกเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อเชิงเส้นทำได้ยาก

ในบริบทของโครงการนี้ การที่ผู้เล่นสามารถย้อนกลับไปเลือกใหม่และเห็นว่าผลลัพธ์เปลี่ยนไป ทำหน้าที่เป็นกระบวนการสะท้อนความคิดในตัวเอง เพราะผู้เล่นได้เปรียบเทียบการตัดสินใจของตนเองกับทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ และได้ตั้งคำถามว่าในสถานการณ์จริงตนเองจะตอบสนองอย่างไร

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม

5.1 โปรแกรม Godot Engine

Godot Engine เป็นเอนจินสำหรับพัฒนาเกม 2 มิติและ 3 มิติ ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยชุมชนนักพัฒนา (Godot Engine, n.d.) คุณสมบัติที่ทำให้ Godot เหมาะสมกับโครงการระดับนักเรียน ได้แก่ การเปิดให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งรายได้ ขนาดโปรแกรมที่เล็ก ระบบฉากและโหนดที่เข้าใจได้ง่าย และการรองรับการส่งออกไฟล์ไปยังหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งสะดวกต่อการนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่น โครงการนี้ใช้ Godot รุ่น 4 เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

GScript เป็นภาษาสคริปต์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Godot Engine มีไวยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับภาษา Python และผูกเข้ากับโครงสร้างโหนดของเอนจินโดยตรง ทำให้เขียนโค้ดที่

ควบคุมฉากและวัตถุในเกมได้กระชับ นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดชนิดข้อมูลแบบสถิต (static typing) ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (Godot Engine, n.d.)

6. งานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง

6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเกมกับการส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างความเห็นอกเห็นใจ

Merry และคณะ (2012) ได้ทำการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมชนิด non-inferiority ในประเทศนิวซีแลนด์ กับวัยรุ่นอายุ 12–19 ปี จำนวน 187 คน ที่มีอาการซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและกำลังแสวงหาความช่วยเหลือ โดยเปรียบเทียบโปรแกรม SPARX ซึ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์หลักการบำบัดความคิดและพฤติกรรม กับการดูแลตามปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาแบบพบหน้า ผลการศึกษาพบว่า SPARX มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าการดูแลตามปกติในการลดอาการซึมเศร้า

งานชิ้นนี้มีความสำคัญต่อโครงการในเชิงหลักการ คือเป็นหลักฐานว่าเกมสามารถส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจของวัยรุ่นได้จริงในระดับที่วัดได้ อย่างไรก็ตาม ต้องระบุให้ชัดว่า SPARX เป็นเครื่องมือเพื่อการบำบัดที่พัฒนาร่วมกับนักวิชาชีพและผ่านการทดสอบทางคลินิก ซึ่งแตกต่างจาก Untitled Illness ที่มีเป้าหมายเพื่อการตระหนักรู้เท่านั้น

Belman และ Flanagan (2010) ได้สังเคราะห์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจให้กลายเป็นหลักการออกแบบเกม พร้อมวิเคราะห์กรณีศึกษาเกม 3 เกม ได้แก่ *PeaceMaker*, *Hush* และ *Layoff* ข้อเสนอสำคัญคือผู้เล่นต้องเข้าสู่เกมด้วยความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจผู้อื่น มิฉะนั้นกลไกการสวมบทบาทจะไม่นำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจโดยอัตโนมัติ

Ferchaud และคณะ (2020) ให้หลักฐานเชิงทดลองที่สนับสนุนว่าการเล่นให้ผลต่างจากการดู โดยใช้เกม *Hellblade: Senua's Sacrifice* เป็นสิ่งเร้า ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้างพบเส้นทางทางอ้อมจากการเล่นไปสู่การลดความต้องการรักษาระยะห่างทางสังคมผ่านตัวแปรส่งผ่านคือ transportation และ identification ตามลำดับ

6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับ Interactive Storytelling และประสบการณ์ของผู้เล่น

Murray (1997) วางรากฐานทางทฤษฎีให้กับการศึกษาการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล โดยเสนอคุณสมบัติสำคัญของสื่อดิจิทัลที่ทำให้การเล่าเรื่องแตกต่างจากสื่อเดิม ขณะที่ Green และ Brock (2000) ให้กรอบเชิงประจักษ์สำหรับอธิบายว่าเหตุใดเรื่องเล่าจึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ผ่านกลไกการถูกดึงเข้าสู่โลกของเรื่อง งานทั้งสองชิ้นถูกใช้ร่วมกันในโครงการนี้เพื่ออธิบายว่าการออกแบบตัวเลือกและการควบคุมจังหวะการเล่าเรื่อง มีผลโดยตรงต่อระดับความเข้าถึงอารมณ์ของผู้เล่น

6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับ Visual Novel และการเล่าเรื่อง

Camingue, Carstensdóttir และ Melcer (2021) เป็นงานที่มีความสำคัญต่อโครงงานนี้มากที่สุดในเชิงคำนิยาม เนื่องจากการทบทวนคำนิยามทางวิชาการของวิชวลโนเวลอย่างเป็นระบบ และเสนอคำนิยามที่รวมองค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน โครงงานนี้จึงใช้คำนิยามดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติครบตามแนวทางที่อ้างถึงหรือไม่ ส่วน Cavallaro (2010) ให้ภาพเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสุนทรียะของแนวเกมนี้ โดยเฉพาะบทบาทของภาพนิ่ง สปรอตตัวละคร และความลุ่มลึกของโครงเรื่องในฐานะคุณลักษณะสำคัญของสื่อ

6.4 การวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับ Untitled Illness

เมื่อพิจารณาจากที่ทบทวนมาทั้งหมด สามารถสรุปช่องว่างและตำแหน่งของโครงงานนี้ได้ดังนี้

ประการแรก งานส่วนใหญ่ที่พิสูจน์ประสิทธิผลได้ชัดเจน เช่น SPARX (Merry et al., 2012) เป็นเครื่องมือเพื่อการบำบัดที่มุ่งเป้าไปที่ตัวผู้มีอาการโดยตรง ขณะที่ Untitled Illness มุ่งไปที่ผู้เล่นทั่วไปในฐานะ "คนรอบข้าง" ซึ่งเป็นกลุ่มที่ Gulliver และคณะ (2010) ระบุว่ามีความสำคัญในการเอื้อให้เกิดการขอความช่วยเหลือ

ประการที่สอง งานที่ศึกษาเกมกับการลดการตีตรา เช่น Ferchaud และคณะ (2020) ใช้เกมที่นำเสนอภาวะทางจิตที่รุนแรงและมองเห็นได้ชัด โครงงานนี้เลือกแนวทางตรงข้าม คือนำเสนอความยากลำบากที่มองไม่เห็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ Ferrari และคณะ (2019) ที่ว่าการนำเสนอที่ไม่ตีตราควรหลีกเลี่ยงการทำให้ภาวะทางจิตกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาด

ประการที่สาม โครงงานนี้เชื่อมโยงทฤษฎีการกำกับอารมณ์ของ Gross และ John (2003) เข้ากับกลไกของเกมโดยตรงผ่านระบบ Emotional Weight ซึ่งเป็นการแปลงข้อค้นพบทางจิตวิทยาให้กลายเป็นกฎของเกม แทนที่จะเป็นเพียงเนื้อหาในบทสนทนา

ประการที่สี่ ข้อจำกัดที่ต้องยอมรับคือ งานวิจัยที่ทบทวนมาชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงภาพเหมารวมที่ฝังลึกด้วยการเล่นเกมเพียงครั้งเดียวเป็นเรื่องยาก (Ferchaud et al., 2020) ดังนั้นการตั้งเป้าหมายของโครงงานจึงควรอยู่ที่การกระตุ้นการสะท้อนความคิดและการตระหนักรู้ มากกว่าการอ้างว่าสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้เล่นได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1

อ้างอิง ****ยังไม่ได้ใช้นะนะ****

กรมสุขภาพจิต. (2565). เปิดผลสำรวจสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19.

<https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2503>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2567). *Mental Health ปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง* [บทความในรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2567].

https://www.nesdc.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/2567_article_q1_001.pdf

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2567). ไทยพบนักศึกษาที่มีภาวะ "เครียด-ซึมเศร้า" 30%. <https://www.thaipbs.or.th/news/content/338472>

Belman, J., & Flanagan, M. (2010). Designing games to foster empathy. *International Journal of Cognitive Technology*, 15(1), 11–21. <https://tiltfactor.org/wp-content/uploads2/cog-tech-si-g4g-article-1-belman-and-flanagan-designing-games-to-foster-empathy.pdf>

Camingue, J., Carstensdóttir, E., & Melcer, E. F. (2021). What is a visual novel? *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CHI PLAY), Article 285, 1–18. <https://doi.org/10.1145/3474712>

Cavallaro, D. (2010). *Anime and the visual novel: Narrative structure, design and play at the crossroads of animation and computer games*. McFarland.

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(1), 113–126. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.44.1.113>

Ferchaud, A., Seibert, J., Sellers, N., & Escobar Salazar, N. (2020). Reducing mental health stigma through identification with video game avatars with mental illness. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 2240. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02240>

Ferrari, M., McIlwaine, S. V., Jordan, G., Shah, J. L., Lal, S., & Iyer, S. N. (2019). Gaming with stigma: Analysis of messages about mental illnesses in video games. *JMIR Mental Health*, 6(5), e12418. <https://doi.org/10.2196/12418>

Godot Engine. (n.d.). *Godot Engine documentation*. Retrieved September 16, 2026, from <https://docs.godotengine.org/en/stable/>

Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(5), 701–721.

<https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.701>

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348–362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>

Gulliver, A., Griffiths, K. M., & Christensen, H. (2010). Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: A systematic review. *BMC Psychiatry*, 10, Article 113. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-113>

Merry, S. N., Stasiak, K., Shepherd, M., Frampton, C., Fleming, T., & Lucassen, M. F. G. (2012). The effectiveness of SPARX, a computerised self help intervention for adolescents seeking help for depression: Randomised controlled non-inferiority trial. *BMJ*, 344, e2598. <https://doi.org/10.1136/bmj.e2598>

Michael, D. R., & Chen, S. L. (2006). *Serious games: Games that educate, train, and inform*. Thomson Course Technology.

Murray, J. H. (1997). *Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace*. Free Press.

World Health Organization. (2024). *Mental health of adolescents*.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>